

HPHP Project Documentation

Online Healthcare Booking Experience Redesign

CUPweb and ER Salute

Team Affordance

Matteo Boscherini

Alessandro Campedelli

Francesco Maria Fuligni

Corso di Usability & User Experience Design

Anno accademico 2025–2026

About This Document

Questo documento raccoglie le card testuali del progetto HPHP e il protocollo di test rapido. Il contenuto è suddiviso in quattro sorgenti LaTeX, uno per ogni fase, inclusi in ordine nel presente documento principale.

I file nativi relativi a blueprint, wireframe, confronto Before/After, guideline e personas restano artefatti separati nelle rispettive directory, così da conservarne la piena modificabilità.

Indice

About This Document	1
Phase A — Ethnographic Research and Assessment	1
Phase B — Feasibility Study	12
Phase C — Design Proposal	17
Phase D — Evaluation	21

Phase A — Ethnographic Research and Assessment

FASE A — Documento 01

Team card

Nome del gruppo

Team Affordance

Membro del team

Campo	Valore
Nome completo	Matteo Boscherini
Matricola	0001239423
E-mail	matteo.boscherini@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale — Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Alessandro Campedelli
Matricola	0001242904
E-mail	alessandr.campedell3@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale — Curriculum B

Campo	Valore
Nome completo	Francesco Maria Fuligni
Matricola	0001246029
E-mail	francesco.fuligni@studio.unibo.it
Corso di studi	Informatica Magistrale — Curriculum C: Sistemi e Reti

FASE A — Documento 02

Client card

Nome del cliente

Regione Emilia-Romagna — Assessorato alle Politiche per la Salute, in collaborazione con CUP 2000 S.c.p.A., società in-house che gestisce tecnicamente i sistemi regionali di prenotazione sanitaria (CUPweb, app ER Salute, Fascicolo Sanitario Elettronico) per conto delle Aziende USL e Ospedaliere del territorio.

Descrizione del cliente

Ente pubblico regionale che coordina i servizi sanitari di tutta l'Emilia-Romagna attraverso le Aziende Sanitarie locali (AUSL Bologna, AUSL Romagna, AUSL Modena, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, AUSL Ferrara e le Aziende Ospedaliere-Universitarie). Il cliente ha già una presenza digitale matura e consolidata: gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, il portale di prenotazione CUPweb, l'app mobile ER Salute, un call center regionale (800 numbers per singola AUSL) e una rete di sportelli fisici e farmacie convenzionate (FarmaCUP). Non lavoriamo direttamente per la Regione: la nostra società di consulenza UX è stata incaricata da un system integrator che opera per conto di CUP 2000 di proporre un redesign dell'esperienza di prenotazione, da presentare come case study per un possibile incarico più ampio.

Nome del tool

CUPweb (portale web, www.cupweb.it) e app mobile ER Salute — sistema regionale di prenotazione online delle prestazioni sanitarie specialistiche (visite ed esami) della Regione Emilia-Romagna.

Come accedere al tool

Via browser su www.cupweb.it, tramite SPID, CIE o credenziali FSE/CUPweb rilasciate agli sportelli; oppure tramite l'app ER Salute (iOS/Android), che consente di prenotare/disdire visite per sé stessi e per i familiari associati (minori o persone tutelate).

Perché il cliente dovrebbe voler finanziare un nuovo tool?

Il canale digitale, pur gratuito e disponibile 24/7, resta sotto-utilizzato dalla fascia più anziana della popolazione, che continua a intasare call center e sportelli fisici o a delegare integralmente la prenotazione a un familiare. Questo genera costi operativi elevati per il servizio sanitario regionale (personale agli sportelli, call center), un alto tasso di mancate presentazioni ("no-show", oggetto peraltro di una sanzione economica prevista dalla L.R. 2/2016), e non risponde agli obiettivi di digitalizzazione della sanità pubblica previsti dal PNRR (Missione 6). Un redesign mirato sulla fiducia e sull'autonomia degli utenti anziani, che valorizzi — invece di scavalcare — il ruolo del caregiver familiare, è coerente con questi obiettivi e giustificabile in termini di riduzione costi.

Product Objectives

Consentire ai pazienti anziani cronici di partecipare più attivamente alla gestione dei propri appuntamenti sanitari — anche quando assistiti da un familiare — riducendo l'ansia da interfaccia, aumentando la fiducia nel canale digitale e trasformando il caregiver da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro.

Business Goals

Riduzione dei costi operativi di call center e sportelli fisici; riduzione del tasso di mancata presentazione agli appuntamenti; incremento della quota di prenotazioni gestite sul canale digitale, in linea con i target nazionali di digitalizzazione della sanità pubblica (PNRR Missione 6, componente 2).

Brand identity

Rafforzare la percezione della sanità pubblica regionale come moderna, efficiente ma allo stesso tempo vicina e inclusiva verso i cittadini più fragili — "la sanità digitale che non lascia indietro nessuno" — differenziandosi da una digitalizzazione percepita come fredda o ostile dalla popolazione anziana.

Success metrics

- Aumento della quota di prenotazioni effettuate (anche in co-presenza con un familiare) direttamente da utenti over 70
- Riduzione del tempo medio necessario per completare una prenotazione
- Punteggio SUS del nuovo prototipo superiore a 68 (soglia di buona usabilità) sul segmento target
- Riduzione del tasso di abbandono durante il flusso di prenotazione
- Riduzione delle chiamate al call center motivate da difficoltà di utilizzo del portale/app

FASE A — Documento 03

User Segmentation card

Dimensioni di segmentazione scelte

- Demografica: età, presenza/assenza di una rete familiare di supporto
- Comportamentale: frequenza di utilizzo del servizio, grado di delega della prenotazione a terzi
- Psicologica: livello di ansia/sfiducia verso gli strumenti digitali, motivazione all'autonomia
- Contestuale: dispositivo disponibile, presenza fisica o meno del caregiver al momento del bisogno, distanza abitativa caregiver-assistito

Motivazione della scelta, relazione con il tool del cliente

Il progetto HPHP richiede di considerare due audience distinte ma interdipendenti: l'utente diretto (che deve usare il servizio ma non è ancora un utente attivo, ed è scettico/impaurito) e l'intermediario (che oggi lo sostituisce integralmente). Per CUPweb/ER Salute, l'utente diretto naturale è il paziente anziano cronico, che deve prenotare ricorrentemente visite ed esami; l'intermediario naturale è il caregiver familiare, che già oggi gestisce gran parte delle pratiche sanitarie del proprio caro. Le dimensioni scelte permettono di distinguere non solo per età anagrafica, ma per il reale grado di autonomia/dipendenza digitale delle due popolazioni, che è il fattore che il redesign deve realmente affrontare.

Segmenti nella dimensione #1 — Utenti diretti (per età e autonomia digitale)

1. "Digital newcomer" — 65-74 anni, competenze digitali di base (messaggistica, videochiamate) ma bloccato/a su procedure strutturate (SPID, moduli, pagamenti online)
2. "Digital avoider" — 75-85+ anni, competenza tecnica quasi nulla, delega totale delle pratiche digitali al caregiver, spesso patologie croniche con necessità di prenotazioni ricorrenti

Segmenti nella dimensione #2 — Intermediari (per relazione con l'assistito)

1. Caregiver convivente — vive con l'assistito, gestisce le prenotazioni "di persona", spesso presente alle visite
2. Caregiver "always-on" a distanza — figlio/a 45-60 anni che non convive con il genitore, gestisce le pratiche da remoto (telefono/PC), spesso lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con poco tempo a disposizione

Numero totale di combinazioni di segmento

2 (utenti diretti) $\times$ 2 (intermediari) = 4 combinazioni possibili.

Combinazioni di segmentazione scelte

- A. Paziente anziano "digital avoider", 75-85 anni, patologia cronica, con caregiver figlio/a disponibile ma non sempre fisicamente presente (utente diretto)
- B. Caregiver "always-on" a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni del genitore, vorrebbe poter delegare gradualmente compiti semplici (intermediario)

Perché le combinazioni scelte sono più rappresentative, sfidanti ed espressive delle altre

I due segmenti scelti rappresentano i due estremi della relazione di dipendenza digitale che il progetto HPHP vuole affrontare: da un lato l'utente completamente dipendente e più a rischio di esclusione digitale (dato Istat 2025: solo il 63,9% delle famiglie di soli anziani ha una connessione internet domestica, contro il 95,1% delle altre famiglie), dall'altro l'intermediario che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "trainer" dell'autonomia del genitore. È inoltre il caso più sfidante dal punto di vista del design (bassa competenza tecnica + alta necessità percepita di controllo/rassicurazione da parte del caregiver a distanza) e più rilevante numericamente: in Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare almeno una volta a settimana, per il 58-60% donne tra i 45 e i 64 anni.

Impatto atteso sul design

Sarà necessaria un'esperienza a due livelli, con percorsi guidati passo-passo e a basso carico cognitivo per l'utente anziano (linguaggio semplice, conferme esplicite, possibilità di richiamare assistenza umana in ogni momento), e strumenti di co-prenotazione/delega controllata per il caregiver a distanza (visibilità sullo stato delle prenotazioni del genitore, notifiche, possibilità di prenotare per conto di un familiare associato mantenendo però il genitore informato e coinvolto). Il design dovrà rendere visibile e graduale il passaggio di competenza dal caregiver al paziente, coerentemente con l'obiettivo di business del cliente.

FASE A — Documento 04 (1/2)

Market research card — Segmento A

Segmento di scelta

Paziente anziano "digital avoider", 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio, con caregiver familiare disponibile ma non sempre fisicamente presente.

Motivazione della scelta

È il segmento più esposto al rischio di esclusione digitale nell'accesso ai servizi sanitari essenziali, e quello su cui un redesign centrato sulla fiducia e sull'autonomia deve dimostrare il maggiore impatto.

Metodo di ricerca utilizzato — Available statistics

Fonti: ISTAT, report "Cittadini e ICT" — Anno 2024 (pubblicato 28 aprile 2025) e Anno 2025 (pubblicato aprile 2026), [istat.it](https://www.istat.it); approfondimenti giornalistici di sintesi (Sanità Informazione, AboutPharma) che commentano gli stessi dati Istat.

- Nel 2025 il 63,9% delle famiglie composte esclusivamente da anziani (65+) dispone di connessione a Internet da casa (era il 60,6% nel 2024), contro il 95,1% delle famiglie non esclusivamente anziane e il 98,7% delle famiglie con almeno un minore.
- Tra gli ultra 75enni il divario di genere nell'uso di Internet è marcato: 38,3% degli uomini contro il 26,5% delle donne (dato 2024).
- Il 57,8% delle famiglie senza connessione a Internet indica come motivo principale la mancanza di capacità di utilizzo, non il costo dei dispositivi o la mancanza di interesse.

- Nel 2024 l'uso di siti/app della Pubblica Amministrazione per scaricare moduli è calato di 9,6 punti percentuali e per prenotare appuntamenti di 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, un segnale di complessità o insoddisfazione d'uso più che di disinteresse.
- Il titolo di studio incide fortemente sull'uso di Internet: 95,8% tra i laureati, 91,6% tra i diplomati, ma solo 69,7% tra chi ha al massimo la licenza media — titolo di studio frequente nella coorte 75-85 anni.

(screenshot delle pagine dei report ISTAT da allegare al materiale supplementare)

DA COMPLETARE — Interviste one-to-one / osservazione sul campo con 3-5 pazienti anziani reali (anche solo telefoniche o in presenza di un familiare), per validare qualitativamente questi dati quantitativi. Traccia di intervista proposta: (1) Come prenoti di solito una visita medica? (2) Hai mai provato CUPweb o l'app ER Salute? Cosa è successo? (3) Chi ti aiuta di solito con queste pratiche? (4) Cosa ti spaventa di più nell'usare il computer/telefono per la sanità? (5) Cosa ti farebbe sentire più sicuro/a nel farlo da solo/a?

Risultati complessivi dell'analisi

I dati confermano quantitativamente ciò che il progetto HPHP presume qualitativamente: gli anziani over 75, soprattutto donne e con basso titolo di studio, sono la fascia più esposta a esclusione digitale nei servizi essenziali come la sanità. La barriera principale non è l'assenza di device o di connessione, ma la percezione di mancanza di competenze — un problema di fiducia e auto-efficacia più che di accesso tecnico.

Impatto sul design

Il design deve minimizzare il carico cognitivo e tecnico richiesto (evitare di esporre da subito procedure complesse come l'autenticazione SPID), offrire percorsi guidati passo-passo con conferme esplicite, validare esplicitamente il ruolo del caregiver come alleato e non sostituto, e prevedere sempre una via di fuga verso l'assistenza umana (call center, farmacia, sportello) senza che questa venga percepita come un fallimento.

FASE A — Documento 04 (2/2)

Market research card — Segmento B

Segmento di scelta

Caregiver familiare "always-on" a distanza, 45-60 anni, alta competenza tecnica, gestisce da remoto le prenotazioni sanitarie di un genitore anziano, intermediario del servizio.

Motivazione della scelta

È il segmento che oggi sostiene il costo (tempo, stress, carico mentale) della mediazione digitale per conto dell'utente diretto, ed è quello che il cliente vuole trasformare da "esecutore" a "facilitatore/allenatore" dell'autonomia del proprio caro — un obiettivo centrale del progetto HPHP.

Metodo di ricerca utilizzato — Available statistics

Fonti: rapporto CNEL-Censis "Il valore sociale del caregiver" (per la Regione Lazio, ottobre 2024); sintesi Istat/EHIS su caregiver familiari riprese da AboutPharma (2026) e Associazione Carer; dati Istat sulla popolazione anziana al 1° gennaio 2026.

- In Italia sono oltre 7 milioni le persone che svolgono attività di caregiving familiare non retribuito, assistendo un anziano, un disabile o un familiare non autosufficiente almeno una volta a settimana.
- Il 58-60% dei caregiver familiari è composto da donne di età compresa tra 45 e 64 anni.

- Circa il 40% dei caregiver, pur essendo in età lavorativa, dichiara di non riuscire a conciliare lavoro e attività di assistenza, con rischio di impoverimento del nucleo familiare.
- Al 1° gennaio 2026 gli over 65 in Italia sono quasi 14,8 milioni (25,1% della popolazione) e gli over 85 hanno superato i 2,5 milioni, con una crescita costante attesa nei prossimi decenni: il fenomeno del caregiving è quindi strutturale e non residuale.

(screenshot dei report citati da allegare al materiale supplementare)

DA COMPLETARE — Intervista/focus group con 2-3 caregiver familiari reali (anche colleghi, conoscenti o parenti disponibili, dichiarandolo onestamente come da istruzioni del corso). Traccia proposta: (1) Come gestisci oggi le prenotazioni sanitarie di tuo padre/madre? (2) Quanto tempo/energia richiede questa attività? (3) Hai mai provato a far prenotare direttamente il tuo familiare? Cosa è successo? (4) Cosa ti darebbe fiducia per lasciargli più autonomia? (5) Che tipo di visibilità/controllo vorresti mantenere comunque?

Risultati complessivi dell'analisi

Il caregiving familiare in Italia è un fenomeno di massa, prevalentemente femminile e concentrato nella fascia 45-64 anni, con un costo personale significativo in termini di tempo e possibilità lavorative. Questo rende particolarmente rilevante, anche dal punto di vista del cliente (riduzione indiretta dei costi sociali), un design che alleggerisca il carico del caregiver senza however toglierne il controllo percepito.

Impatto sul design

Il design dovrà offrire strumenti di co-gestione (visibilità sulle prenotazioni del familiare, notifiche, possibilità di intervenire solo quando necessario) piuttosto che di sostituzione totale, con una progressione esplicita e graduale di autonomia delegata al paziente, in modo che il caregiver possa fidarsi di "lasciare andare" un compito alla volta.

FASE A — Documento 05a

Assessment of existing resource card — Tool del cliente

Nome del tool

CUPweb (portale, www.cupweb.it) e app mobile ER Salute — Regione Emilia-Romagna.

Piattaforme

Sito web responsive-limitato (desktop e browser mobile); app nativa Android e iOS (una versione Windows Phone risulta dismessa).

Scopo principale, operazioni consentite, adeguatezza percepita agli standard professionali

Il tool consente di prenotare, disdire e modificare appuntamenti per prestazioni sanitarie specialistiche (SSN e Libera Professione), pagare online una prenotazione, consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico e ristampare i promemoria degli appuntamenti. Dal punto di vista tecnico il sito è funzionante e integrato con gli standard nazionali di identità digitale (SPID, CIE, CNS), ma l'impostazione grafica e architetture risulta datata rispetto agli standard di design contemporanei della Pubblica Amministrazione (confrontabile con le linee guida di design.gov.it): navigazione a menu testuali densi, assenza di una gerarchia visiva chiara, servizi distribuiti su domini diversi e visivamente scollegati tra loro (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it, support.fascicolo-sanitario.it).

Principali punti di forza, motivo della scelta

- Gratuito e disponibile 24/7, riduce la necessità di recarsi fisicamente a uno sportello

- Integrazione con gli standard nazionali di identità digitale (SPID/CIE/CNS), coerente con l'infrastruttura pubblica
- Copertura territoriale capillare su tutta la Regione Emilia-Romagna, con canali alternativi complementari (farmacie FarmaCUP, call center, sportelli fisici) per chi non può/vuole usare il digitale
- È il vero tool che il cliente ci ha chiesto di ridisegnare: analizzarlo nella sua forma reale, difetti inclusi, è indispensabile per un redesign credibile

Principali punti di debolezza

- Autenticazione obbligatoria complessa (SPID livello 2/CIE) anche solo per prenotare, con re-autenticazioni periodiche forzate che gli utenti reali segnalano come fonte di frustrazione ricorrente nelle recensioni pubbliche dell'app
- Servizi distribuiti su più domini/sottodomini esterni tra loro visivamente scollegati, un pattern che in un utente anziano diffidente può generare sospetto di phishing invece di fiducia
- Problemi di accessibilità segnalati da utenti con lettori di schermo, nonostante la dichiarazione di accessibilità pubblicata
- Interfaccia informativa fortemente testuale, con bassa gerarchia visiva e nessun elemento di orientamento per un utente al primo utilizzo
- Le funzioni disponibili senza autenticazione sono minime (solo pagamento e disdetta), il che costringe da subito l'utente meno esperto ad affrontare la parte più complessa del flusso (identità digitale) prima ancora di capire il valore del servizio

First Impressions — Direct Analysis

Analisi diretta secondo le categorie delle User Focus Guidelines (<https://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html>): Navigation, Search, Content organisation & layout, Content and titles, Page layout, Shopping/task completion (qui: prenotazione), Trust and credibility. Il foglio di valutazione completo con i punteggi guideline-per-guideline va compilato nel file Excel dedicato; qui riportiamo la sintesi delle criticità più rilevanti riscontrate.

Elenco delle criticità principali

- [Navigation] I link di primo livello ("Disdici", "Prenota", "Paga", "Informazioni") portano a domini esterni differenti senza preavviso visivo — viola la linearità di navigazione attesa
- [Trust and credibility] Il passaggio tra domini diversi (cupweb.it → pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) senza un design coerente indebolisce la percezione di affidabilità, un fattore critico proprio per l'utente anziano diffidente che è il target del progetto
- [Page layout] Assenza di elementi visivi (icone, immagini, colori distintivi) che aiutino il riconoscimento rapido delle azioni disponibili; il testo è l'unico veicolo informativo
- [Content and titles] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata in linguaggio semplice (es. "CNS", "SPID", "impegnativa dematerializzata") esposta senza tooltip o spiegazioni contestuali
- [Task completion] Il completamento della maggior parte delle azioni richiede autenticazione forte fin dal primo passo, senza un percorso dimostrativo o guidato per il nuovo utente
- [Accessibility] Segnalazioni pubbliche di incompatibilità con screen reader per utenti non vedenti, nonostante l'esistenza di una dichiarazione di accessibilità formale

First Impressions — Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il task "disdire un appuntamento già fissato, partendo da un link ricevuto per SMS, senza credenziali SPID già pronte" — scenario realistico per il segmento A (paziente anziano).

Elenco delle criticità principali

- Il task di disdetta è tra i pochi eseguibili senza autenticazione forte, ma non è immediatamente distinguibile in home page da quello di prenotazione — richiede comunque lettura attenta dei menu
- Non è chiaro, senza leggere il testo esplicativo per intero, quale sia la differenza fra i canali "Servizio Sanitario Nazionale" e "Libera Professione" al momento della scelta, pur essendo un bivio obbligato del flusso
- Recensioni reali dell'app ER Salute segnalano che la cronologia dei documenti/appuntamenti non è ordinabile o ricercabile per data, costringendo a scorrimenti lunghi — un problema di efficienza soprattutto per un utente con minore dimestichezza con lo scroll touch
- Il cambio dell'obbligo di autenticazione (introduzione dell'obbligo SPID dove prima bastava il riconoscimento biometrico) è stato vissuto da utenti reali come un peggioramento improvviso e non comunicato in modo comprensibile, minando la fiducia già costruita

FASE A — Documento 05b

Assessment of existing resource card — Tool competitor

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia) — piattaforma privata di prenotazione di visite mediche.

Piattaforme

Sito web (miodottore.it) responsive, app nativa Android e iOS.

Scopo principale, operazioni consentite, adeguatezza percepita agli standard professionali

Piattaforma privata (non SSN) che permette di cercare oltre 240.000 medici e specialisti per categoria, città o assicurazione sanitaria, leggere recensioni di altri pazienti, prenotare una visita in pochi passaggi, ricevere promemoria, gestire/annullare appuntamenti e contattare lo specialista via messaggi o videoconsulto. Il design è moderno, coerente con gli standard commerciali attuali (ricerca a faccette, mappa, card con foto, iconografia chiara).

Principali punti di forza, motivo della scelta

- Un solo dominio, un solo brand coerente per tutto il flusso — nessun salto percepito di fiducia come invece accade in CUPweb
- Registrazione/accesso semplificato (email o numero di telefono), senza richiedere un'identità digitale certificata come SPID per la sola consultazione o prenotazione
- Interfaccia fortemente visiva: foto dei professionisti, valutazioni a stelle, filtri chiari, mappa — riduce il carico cognitivo rispetto al solo testo
- Promemoria automatici e possibilità di messaggistica diretta col professionista, elementi di rassicurazione assenti in CUPweb
- È stato scelto come termine di paragone perché, pur avendo uno scopo diverso (mercato privato vs. sanità pubblica), rappresenta un benchmark di riferimento per gli standard di semplicità che un utente anziano o il suo caregiver oggi si aspettano da un'app di prenotazione sanitaria, avendola probabilmente già vista usare da altri familiari

Principali punti di debolezza

- Le recensioni sono moderate secondo linee guida della piattaforma stessa, il che ha generato dubbi pubblici sulla loro genuinità/affidabilità — un problema di trasparenza che il progetto HPHP (dove la fiducia è centrale) deve evitare di replicare
- Alcuni utenti segnalano un flusso di login inutilmente frammentato tra browser, modali e rimando all'app store, con conseguente frustrazione

- Il servizio è privato: non integra il Servizio Sanitario Nazionale, le esenzioni ticket, o il Fascicolo Sanitario Elettronico — quindi non risolve da solo il caso d'uso del cliente, ma resta valido come fonte di ispirazione sul piano dell'esperienza
- Il modello di business (i medici pagano per essere visibili) può introdurre bias nei risultati di ricerca, un problema di trasparenza inapplicabile ma da tenere presente come contro-esempio

First Impressions — Direct Analysis

Elenco delle criticità principali

- [Trust and credibility] Il sistema di recensioni moderate genera sospetto in una parte degli utenti, minando proprio l'elemento di fiducia che dovrebbe essere il punto di forza
- [Task completion] Il login, secondo segnalazioni reali, può risultare inutilmente lungo (redirect multipli tra app e browser) su alcuni dispositivi
- [Navigation] Buona nel complesso: ricerca a faccette e mappa riducono il carico di navigazione libera, un pattern che vale la pena studiare per il redesign

First Impressions — Reverse Analysis

Analisi condotta simulando il task "trovare e prenotare una visita specialistica vicino a casa, come utente al primo accesso".

Elenco delle criticità principali

- Il primo accesso è comunque mediato da un passaggio di registrazione, anche se più leggero di SPID — un piccolo attrito resta anche nel miglior competitor osservato
- La grande quantità di filtri e opzioni (assicurazione, videoconsulto, tipo di visita) può risultare eccessiva per un utente che cerca semplicemente "la prossima visita disponibile", un rischio di sovraccarico da tenere presente anche nel nostro redesign

FASE A — Documento 06a

Preliminary User testing card — Tool del cliente

Questo test riguarda CUPweb / app ER Salute, il tool da ridisegnare.

Nome del tool

CUPweb (portale) / app ER Salute

Protocollo di test

Setup della sessione di test

Test in presenza, presso il domicilio del soggetto o in un luogo neutro familiare al soggetto (per ridurre l'ansia da contesto), su dispositivo del soggetto stesso quando possibile (smartphone o PC abitualmente usato), altrimenti su un dispositivo del team preconfigurato in modo identico. Un membro del team fa da assistente/osservatore, un secondo prende appunti.

Metodo di test

- Discount usability testing (3 soggetti, in linea con le indicazioni del corso per test preliminari)

Elenco dei task da testare

- T1 — Accedere al portale/app e individuare come prenotare una visita specialistica (senza completare la prenotazione)
- T2 — Disdire un appuntamento fittizio già presente nell'account demo/test
- T3 — Individuare dove e come chiedere aiuto/assistenza in caso di difficoltà

Metodologia di test

- Thinking aloud per i task T1 e T3 (per comprendere il ragionamento e le difficoltà percepite)
- Bottom line data per il task T2 (per misurare efficienza/efficacia reale senza interferenze)

Metriche di test

- Success (task completato sì/no)
- Efficiency (tempo impiegato)
- Efficacy (accuratezza del risultato ottenuto)
- Errors (numero e tipo di errori commessi)
- Learnability (miglioramento fra primo e secondo tentativo, se applicabile)
- Satisfaction (tramite questionario SUS)

Reclutamento dei soggetti

DA COMPLETARE — Da completare con soggetti reali. Requisiti minimi: almeno 2-3 persone che rientrino nel segmento A (65-85 anni, bassa/media competenza digitale) e/o segmento B (caregiver familiare 45-60 anni). Per ciascun soggetto indicare: nome fittizio, età, genere, competenza tecnica e di dominio, somiglianza con il segmento scelto, relazione con il team (es. "nonna di un membro del team", "vicino di casa"). Almeno due di questi soggetti dovranno essere ricontattati nella Fase D per valutare il redesign: pianificare fin da ora una seconda sessione con loro.

Modalità di reclutamento dei soggetti

DA COMPLETARE — Da completare: descrivere onestamente come sono stati trovati i soggetti (es. rete familiare/amicale dei membri del team, associazioni per anziani del quartiere, centri sociali, parrocchie, ecc.).

Motivazione della scelta dei soggetti

DA COMPLETARE — Da completare con onestà, come richiesto esplicitamente dalla card originale: se i soggetti sono stati scelti per disponibilità/vicinanza più che per rappresentatività statistica, va dichiarato esplicitamente.

Le sezioni "Test #1: Subject..." (nome fittizio, data, assistente, contesto, dati qualitativi e quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google fornito dal corso, suggerimenti dei soggetti, riflessioni utili per il design) andranno aggiunte — una per ciascun soggetto reale testato — non appena i test saranno stati condotti. Il protocollo sopra è pronto per essere eseguito.

FASE A — Documento 06b

Preliminary User testing card — Tool competitor

Questo test riguarda MioDottore.

Nome del tool

MioDottore (Doctolib Italia)

Protocollo di test

Setup della sessione di test

Stesso setup del test sul tool del cliente (in presenza, dispositivo abituale del soggetto quando possibile), idealmente con gli stessi soggetti reclutati per il test su CUPweb, per poter confrontare le esperienze a parità di persona.

Metodo di test

- Discount usability testing (3 soggetti)

Elenco dei task da testare

- T1 — Cercare uno specialista di una categoria a scelta nella propria città (senza completare la prenotazione)
- T2 — Individuare come si annullerebbe un appuntamento già fissato
- T3 — Individuare dove e come si contatta il professionista in caso di dubbi

Metodologia di test

- Thinking aloud per T1 e T3
- Bottom line data per T2

Metriche di test

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti

DA COMPLETARE — Idealmente gli stessi soggetti del test 06a, per un confronto diretto delle due esperienze. Vedi istruzioni nella card 06a.

Modalità di reclutamento dei soggetti

DA COMPLETARE — Vedi card 06a.

Motivazione della scelta dei soggetti

DA COMPLETARE — Vedi card 06a.

Anche qui, le sezioni "Test #1: Subject..." per ciascun soggetto reale vanno aggiunte a valle dell'esecuzione dei test. Protocollo pronto per essere eseguito.

FASE A — Documento 07

Conclusions and design recommendation card

Elenco delle criticità per importanza

Elenco preliminare basato sulle sole Assessment card (05a/05b). Andrà integrato e ri-prioritizzato con impatto/persistenza reali una volta raccolti i dati dello User testing (06a/06b).

- [ID-01] Autenticazione obbligatoria complessa (SPID/CIE) richiesta fin dal primo passo, anche per compiti semplici — impatto: alto; persistenza: alta
- [ID-02] Frammentazione tra domini/sottodomini scollegati tra loro (cupweb.it, pagonline-sanita.it, fascicolo-sanitario.it) — impatto: alto (mina la fiducia); persistenza: alta
- [ID-03] Interfaccia poco gerarchizzata, prevalentemente testuale, priva di elementi visivi di orientamento — impatto: medio; persistenza: alta
- [ID-04] Terminologia tecnico-burocratica non spiegata (SPID, CNS, impegnativa dematerializzata) — impatto: medio; persistenza: media
- [ID-05] Assenza di un percorso guidato/dimostrativo per il nuovo utente — impatto: alto; persistenza: alta
- [ID-06] Problemi di accessibilità per utenti con tecnologie assistive — impatto: alto (per il sottoinsieme di utenti coinvolti); persistenza: media
- [ID-07] Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile nell'app — impatto: basso-medio; persistenza: media

Tabella riassuntiva dei punteggi SUS

DA COMPLETARE — Da compilare con i punteggi reali ottenuti dal modulo Google SUS somministrato ai soggetti di test (card 06a e 06b). Struttura pronta: una colonna per soggetto, righe per le 10 domande standard SUS, riga Totale, Media,

Varianza. Se la varianza tra soggetti risultasse elevata, andranno indagate le ragioni (es. soggetti con competenze digitali molto diverse tra loro) e valutata l'opportunità di soggetti aggiuntivi.

Curva di urgenza

DA COMPLETARE — Da costruire (almeno $\text{impatto} \times \text{persistenza}$) una volta confermate le criticità con i dati di test reali, usando gli identificatori [ID-01...ID-07] sopra elencati come base di partenza, integrati con quanto emerso dai test.

Raccomandazioni di design preliminari

Raccomandazioni preliminari, connesse alle criticità individuate nell'assessment. Andranno arricchite/confermate con le evidenze dello user testing prima della stesura finale.

- [R-01] (collegata a ID-01, ID-05) Introdurre un percorso "a bassa soglia" iniziale che permetta di esplorare il servizio (es. vedere disponibilità, capire come funziona) prima di richiedere l'autenticazione forte, spostando SPID/CIE solo al momento realmente necessario
- [R-02] (collegata a ID-02) Unificare visivamente tutti i touchpoint del servizio (prenotazione, pagamento, fascicolo) sotto un'unica identità grafica coerente, anche se tecnicamente restano sistemi diversi, per non rompere la fiducia dell'utente durante il percorso
- [R-03] (collegata a ID-03, ID-04) Introdurre gerarchia visiva (icone, colori, dimensioni) e microcopy in linguaggio semplice con spiegazioni contestuali per i termini tecnici (tooltip, esempi)
- [R-04] (collegata a ID-05) Progettare un flusso guidato passo-passo per il primo utilizzo, con conferme esplicite ad ogni passaggio e possibilità di richiamare assistenza (caregiver o operatore) senza percepirlo come un fallimento
- [R-05] (collegata a ID-06) Verificare e correggere la compatibilità con tecnologie assistive (screen reader) in coerenza con la dichiarazione di accessibilità già pubblicata dal cliente
- [R-06] (collegata al segmento B / caregiver) Introdurre una modalità di "co-gestione" che dia visibilità al caregiver sulle prenotazioni del familiare pur lasciando che sia quest'ultimo, quando possibile, a compiere l'azione finale — per costruire gradualmente autonomia invece di sostituirla

Phase B — Feasibility Study

FASE B — Documento 01

Team card

Vedi Fase A, Documento 01 — Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

FASE B — Documento 02a

Persona and use case card — Protagonista

[Foto di Pina — sostituire con immagine reale, es. da Unsplash/Pexels, licenza libera]

Nome della persona

Giuseppina "Pina" Ferretti

"Se non c'è qualcuno che mi aiuta, io non riesco a prenotare niente da sola."

Segmento corrispondente

Segmento A di Fase A — Paziente anziano "digital avoider", 75-85 anni, patologia cronica, utente diretto del servizio.

Descrizione della persona

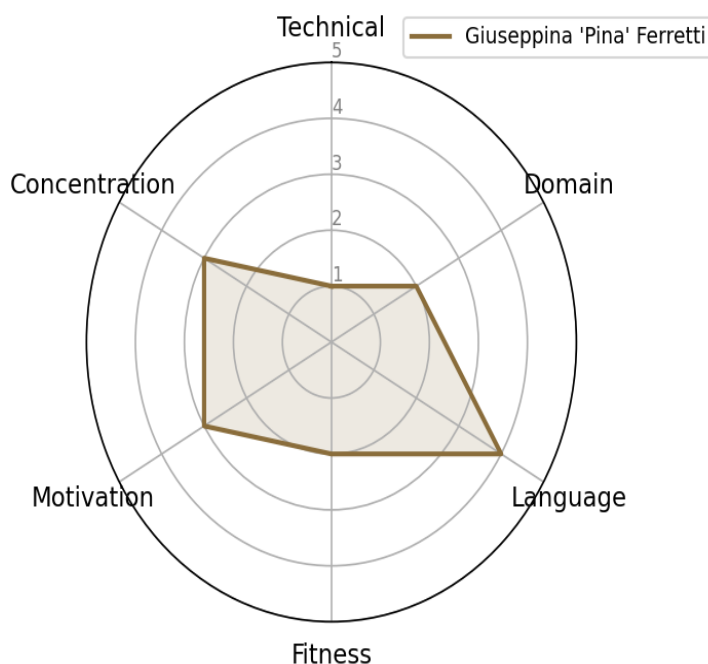
Dati di base

- 78 anni, donna, italiana, pensionata (ex operaia tessile)
- Vive sola in un appartamento a Ravenna; il marito è mancato 6 anni fa
- Diabete di tipo 2 e ipertensione: visite diabetologiche ed esami del sangue ogni 4-6 mesi
- Lieve difficoltà visiva (porta occhiali da presbite) e un leggero tremore alle mani che rende difficile toccare con precisione elementi piccoli su schermo
- Possiede uno smartphone Android semplice, regalato dalla figlia due anni fa

Background e caratteristiche psicologiche

Pina ha lavorato tutta la vita in una manifattura tessile, senza mai usare un computer per lavoro. È abituata a gestire le pratiche di persona: sportelli, farmacie, ambulatori. È una donna precisa, orgogliosa della propria indipendenza, ma consapevole dei propri limiti con la tecnologia. Teme di "rompere qualcosa" o di essere truffata online, e prova un certo imbarazzo nel dover chiedere aiuto continuamente alla figlia, pur dipendendo da lei per quasi tutte le pratiche digitali. Ha un desiderio latente — mai dichiarato apertamente — di riuscire a fare almeno le cose più semplici da sola.

Profilo di competenze — Pina (protagonista)



Descrizione del caso d'uso #1 — La visita diabetologica di controllo

Narrativa del caso d'uso

Pina deve prenotare la visita diabetologica di controllo semestrale. Prova ad aprire l'app ER Salute sul suo telefono, ma non ricorda la password SPID e non riesce a distinguere tra i pulsanti "Prenota" e "Informazioni", entrambi presentati come semplice testo. Dopo due tentativi falliti e un messaggio di errore che non capisce, chiama la figlia Elena, interrompendola durante una riunione di lavoro. Pina si sente in colpa per il disturbo arrecato e, la volta successiva, rinuncia a riprovare da sola, rafforzando così la propria dipendenza dalla figlia invece di ridurla.

Considerazioni conclusive

Impatto della persona sul design

- [P-01] L'autenticazione deve avere un'alternativa a bassa soglia per compiti a basso rischio (consultare, non modificare), rimandando SPID solo quando serve davvero
- [P-02] I pulsanti di azione devono essere visivamente distinti (colore, forma, icona) e non semplice testo, per compensare le difficoltà visive e di precisione motoria
- [P-03] Il linguaggio deve essere semplice e rassicurante, con conferme esplicite che riducano la paura di "sbagliare" o "rompere qualcosa"

Impatto del caso d'uso #1 sul design

- [U1-01] Il flusso di prenotazione per patologie croniche dovrebbe permettere di richiedere una visita di controllo ricorrente con un numero minimo di passaggi, riconoscendo lo storico del paziente
- [U1-02] In caso di errore, il sistema deve offrire un percorso di recupero chiaro (es. 'chiedi aiuto ora' con contatto diretto) prima che l'utente abbandoni e rinunci definitivamente

FASE B — Documento 02b

Persona and use case card — Non protagonista

[Foto di Elena — sostituire con immagine reale, es. da Unsplash/Pexels, licenza libera]

Nome della persona

Elena Ferretti

“Vorrei che mia madre potesse cavarsela da sola per le cose semplici, così mi preoccuperei solo per l'importante.”

Segmento corrispondente

Segmento B di Fase A — Caregiver familiare "always-on" a distanza, 45-60 anni, intermediario del servizio.

Descrizione della persona

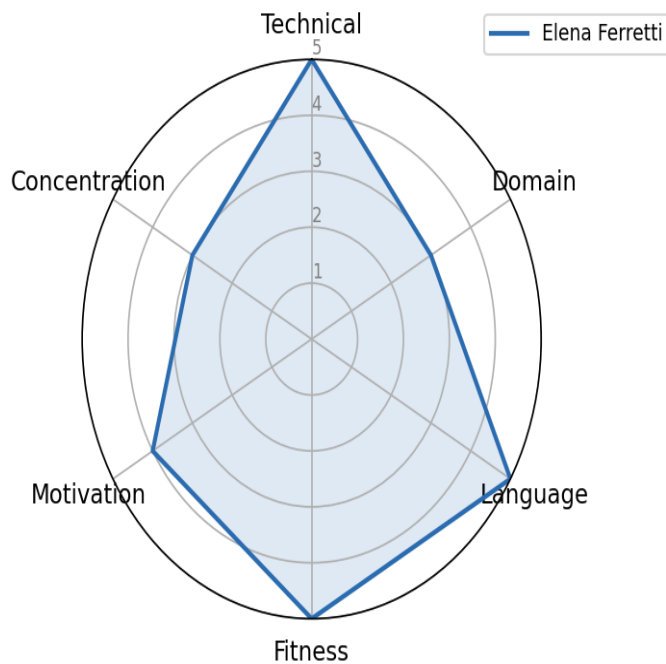
Dati di base

- 52 anni, donna, italiana, impiegata amministrativa a tempo pieno
- Vive a Bologna, a circa un'ora di auto/treno dalla madre Pina, che vive a Ravenna
- Sposata, due figli adolescenti; gestisce famiglia, lavoro e assistenza alla madre contemporaneamente
- Buona competenza digitale, usa quotidianamente PC e smartphone per lavoro

Background e caratteristiche psicologiche

Elena è cresciuta con la tecnologia e non ha alcuna difficoltà a usare app e siti web. Gestisce da anni le pratiche sanitarie della madre, spesso interrompendo il proprio lavoro per farlo. È una persona organizzata ed efficiente, ma il carico di responsabilità che si accumula col tempo — lavoro, figli, madre — la porta a momenti di stanchezza e frustrazione. Non vuole "sostituirsi" completamente alla madre: vorrebbe piuttosto che Pina potesse gestire in autonomia almeno i compiti più semplici, così da poter concentrare il proprio tempo limitato sulle situazioni davvero complesse.

Profilo di competenze — Elena (non protagonista)



Descrizione del caso d'uso #1 — La disdetta urgente dall'ufficio

Narrativa del caso d'uso

Elena riceve, durante l'orario di lavoro, una chiamata dalla madre Pina che non riesce a disdire una visita già prenotata perché è cambiato un impegno di famiglia. Elena deve interrompere il proprio lavoro, aprire l'app da remoto, capire quale prenotazione tra quelle associate al profilo del genitore va disdetta, e risolvere il problema in pochi minuti prima di tornare a una riunione. Vorrebbe che la madre potesse gestire da sola almeno la disdetta — un'azione che considera semplice — ma il sistema attuale non la rende comprensibile per lei.

Considerazioni conclusive

Impatto della persona sul design

- [P-04] Il design deve offrire a un caregiver a distanza una visibilità chiara (non invasiva) sulle prenotazioni del familiare associato, senza dover richiamare a memoria dettagli specifici ogni volta
- [P-05] Deve esistere un meccanismo di delega progressiva: azioni semplici e a basso rischio (es. disdetta) rese eseguibili in autonomia dal paziente, con il caregiver informato ma non necessariamente coinvolto

Impatto del caso d'uso #1 sul design

- [U2-01] La disdetta di un appuntamento dovrebbe essere l'azione più semplice e accessibile del sistema (minimo numero di passaggi, nessuna scelta ambigua tra più prenotazioni simili)
- [U2-02] Il caregiver dovrebbe poter ricevere notifiche automatiche sullo stato delle prenotazioni del familiare, riducendo la necessità di intervenire solo su chiamata d'emergenza

FASE B — Documento 03

Cast card

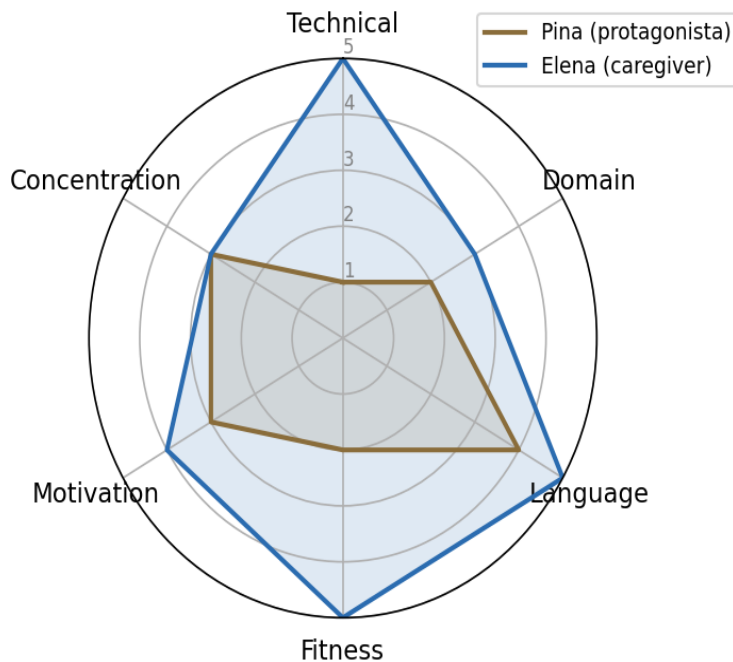
Cast con ruoli e segmenti

- Protagonista: Giuseppina "Pina" Ferretti — Segmento A (paziente anziano, utente diretto)

- Non protagonista: Elena Ferretti — Segmento B (caregiver familiare, intermediario)

Grafico cumulativo dei tratti di personalità

Cast — confronto dei profili



Il file Excel "HHPH_FaseB_PersonasAndCast.xlsx" allegato contiene i dati sorgente e i grafici radar nativi, modificabili.

Impact on design

Impatto del cast sul design (sintesi cumulativa)

- [C-01] (= P-01+P-02+P-03) Il design deve essere utilizzabile con competenza tecnica minima, alta chiarezza visiva del linguaggio e delle azioni, e un tono rassicurante che riduca l'ansia da errore — requisiti derivati dal profilo di Pina, il più critico del cast su queste dimensioni
- [C-02] (= P-04+P-05) Il design deve offrire al caregiver uno strumento di supervisione leggera e delega progressiva, che riduca il carico di intervento diretto senza eliminarne il controllo — requisito derivato dal profilo di Elena
- [C-03] Poiché il cast comprende due profili agli estremi opposti sulla dimensione Technical (Pina=1, Elena=5), il sistema deve poter presentare esperienze differenziate (o adattive) per i due ruoli, pur restando parte dello stesso ecosistema di prodotto

Impatto dei casi d'uso sul design (sintesi cumulativa)

- [C-04] (= U1-01+U1-02) Le prenotazioni ricorrenti per patologie croniche vanno semplificate riconoscendo lo storico del paziente, con un percorso di recupero assistito in caso di errore
- [C-05] (= U2-01+U2-02) La disdetta deve essere l'azione più semplice del sistema, e il caregiver deve poter essere informato automaticamente senza dover intervenire ogni volta di persona
- Questi requisiti, numerati con codice [C-0x], saranno ripresi esplicitamente nella Fase C in fase di Information Architecture, Interaction Design e Wireframe.

Phase C — Design Proposal

FASE C — Documento 02

Information Architecture card

Era necessaria una fase di progettazione specifica per l'Information Architecture del tool? Perché?

Sì. L'assessment di Fase A ha individuato come criticità principale la frammentazione del servizio su più domini/sottosistemi (cupweb.it, pagonlinesanita.it, fascicolo-sanitario.it) organizzati secondo la struttura interna dei sistemi informativi regionali piuttosto che secondo i compiti dell'utente (requisiti [ID-02], [ID-05] di Fase A; [C-01], [C-03] di Fase B). Una riprogettazione dell'interazione senza prima ridisegnare l'architettura informativa avrebbe lasciato intatta la causa principale di disorientamento e sfiducia rilevata nell'assessment. Una fase di IA dedicata è quindi necessaria e propedeutica a Interaction Design, Blueprint e Wireframe.

È stato scelto un approccio top-down, bottom-up o misto per l'Information Architecture dell'applicazione?

- Approccio misto: top-down per definire le macro-categorie di primo livello a partire dagli obiettivi di business e dai bisogni noti degli utenti (Fase A/B); bottom-up per validare etichette e raggruppamenti a partire dai task concreti emersi dai casi d'uso delle personas (booking, disdetta, consultazione, delega) e dalle criticità reali osservate nell'assessment.

Se la scelta è diversa da quella del tool esistente, motivare la scelta

Il tool esistente (CUPweb/ER Salute) riflette un'organizzazione essenzialmente bottom-up e system-driven: ogni sistema informativo regionale (prenotazione, pagamento, fascicolo) espone la propria interfaccia separata, e l'utente deve ricostruire da solo il percorso tra i vari sistemi. Questo approccio è comprensibile dal punto di vista tecnico (sistemi sviluppati da fornitori/tempi diversi) ma è in diretto conflitto con i requisiti [P-01]/[P-02] di Fase B (Pina ha competenza tecnica minima e bisogno di percorsi chiari). Abbiamo scelto un approccio guidato dai task dell'utente (top-down) proprio per correggere questa criticità, mantenendo però una validazione bottom-up sui casi d'uso reali per evitare di creare un'architettura teoricamente elegante ma poco aderente ai bisogni concreti.

Quali sono le principali decisioni sull'organizzazione e sul sistema di etichettatura? Sono diverse rispetto al tool esistente?

Sì, sostanzialmente diverse. Le etichette passano da un'organizzazione per sistema ("CUPweb", "Pagonlinesanita", "Fascicolo Sanitario") a un'organizzazione per compito dell'utente:

- "Prenota una visita" (unico punto di ingresso, sostituisce le etichette 'Prenota'/'Disdici' separate quando l'intento non è ancora chiaro)
- "I miei appuntamenti" (visualizza, disdice, modifica — riunisce ciò che oggi è sparso tra sistemi diversi)
- "Le mie prescrizioni" (impegnative dematerializzate, terminologia tecnica sostituita con linguaggio semplice)
- "Chi assisto" / "Chi mi assiste" (nuova sezione, esplicita la relazione caregiver-paziente prevista dai requisiti [P-04]/[P-05]/[C-02] di Fase B, oggi assente come concetto esplicito nel tool)
- "Serve aiuto?" (canale di assistenza sempre visibile e allo stesso livello delle altre voci principali, non relegato in fondo alla pagina)

Il sistema di etichettatura adotta linguaggio naturale orientato al compito ("Prenota una visita") invece che al nome del sistema tecnico, e i termini burocratici (SPID, CNS, impegnati-

va dematerializzata) restano disponibili ma non sono più usati come etichette di navigazione primaria.

Quali sono i campi di metadati più rilevanti? Sono diversi rispetto al tool esistente?

Rispetto al tool esistente, che tratta ogni prenotazione come un record isolato, introduciamo metadati aggiuntivi funzionali agli obiettivi del redesign:

- Tipo di prestazione (visita, esame, screening) — già presente nel tool esistente
- Ricorrenza (flag "prestazione ricorrente/cronica") — nuovo, abilita il flusso semplificato [U1-01] di Fase B per pazienti cronici come Pina
- Account collegato/delegante (relazione paziente-caregiver) — nuovo, necessario per abilitare [P-04]/[U2-02] (visibilità del caregiver sulle prenotazioni del familiare)
- Livello di autenticazione richiesto per l'azione (nessuna, leggera, forte/SPID) — nuovo, necessario per abilitare [P-01] (percorso a bassa soglia prima dell'autenticazione forte)
- Canale di provenienza dell'azione (self, delegata dal caregiver) — nuovo, per tracciabilità e fiducia reciproca tra paziente e caregiver

Come si intende progettare il sistema di navigazione? È diverso rispetto al tool esistente?

Sì. Il tool esistente non ha una vera navigazione unificata: ogni dominio ha il proprio menu locale. Proponiamo una navigazione a 5 voci di primo livello, identica per tutte le pagine e coerente su web e app (requisito [ID-02]/[ID-05] di Fase A): Prenota una visita, I miei appuntamenti, Le mie prescrizioni, Chi assisto/Chi mi assiste, Serve aiuto? Le pagine profonde (es. dettaglio di una singola prenotazione) mantengono sempre un percorso di ritorno esplicito (breadcrumb semplificato: "< Torna ai miei appuntamenti") invece del semplice tasto "indietro" del browser, su cui il tool attuale fa affidamento implicito.

Descrivere brevemente le scelte su:

Browsing aids

- Scorciatoia "Prenota di nuovo" per le prestazioni ricorrenti, in cima a "I miei appuntamenti" (assente nel tool esistente)
- Sezione "Prossimo appuntamento" sempre visibile in home, per orientare subito l'utente sulla prossima azione rilevante
- Per il caregiver: vista aggregata "Chi assisto" con lo stato sintetico delle prenotazioni di tutti i familiari collegati

Search aids

Coerentemente con l'assessment di Fase A (il tool esistente non ha una vera ricerca testuale libera), non introduciamo una ricerca a testo libero come elemento primario: il volume di contenuti non lo giustifica e rischierebbe di aggiungere complessità per il segmento A. Introduciamo invece filtri strutturati e guidati nel flusso di prenotazione (tipo di prestazione, ambito territoriale, fascia oraria), pensati per essere selezionati per tocchi successivi piuttosto che digitati.

Contents and Tasks

Task primario: prenotare/disdire una visita o un esame. Task secondario ricorrente: consultare lo stato di una prescrizione. Task secondario per il caregiver: supervisionare le prenotazioni di un familiare e, se necessario, agire per suo conto in modo tracciabile. Contenuti puramente informativi (es. guide, normativa) restano accessibili ma vengono spostati fuori dal percorso primario, in una sezione "Serve aiuto?" dedicata, per non competere visivamente con le azioni di task (coerente con [ID-03]/[R-03] di Fase A).

Invisible components

- Gestione unificata della sessione di autenticazione tra i sotto-sistemi oggi separati (evita le re-autenticazioni ripetute segnalate come criticità in Fase A, [ID-01])
- Livelli di autenticazione differenziati per tipo di azione (consultazione vs modifica vs pagamento), invisibili all'utente ma alla base del percorso 'a bassa soglia' richiesto da [P-01]
- Collegamento dati paziente-caregiver (relazione di delega), con log delle azioni svolte per conto di un familiare, per garantire trasparenza reciproca
- Motore di notifica (promemoria appuntamenti, conferme disdetta) condiviso tra l'account del paziente e quello del caregiver collegato

FASE C — Documento 06

Design summary card

Per ciascuna versione del design prodotta, create una cartella nella cartella allegati con un nome significativo e aggiungetevi i file di design corrispondenti. Queste cartelle verranno usate in Fase D.

Versioni del design come consegnate

Version 0 (prima di qualsiasi valutazione formale)

Nome cartella	v0_wireframe_iniziale
Data / ora di completamento	[da compilare con la data reale di completamento]

Corrisponde ai materiali già prodotti in questo pacchetto: Information Architecture card, Blueprint (Documento 03), Wireframes (Documento 04) e Before/After (Documento 05). Questa versione non ha ancora ricevuto alcuna valutazione formale (né ispezione né test utente) ed è quella che sarà sottoposta a valutazione in apertura di Fase D.

Version 1 (duplicare se necessario)

Nome cartella	[da compilare, es. v1_dopo_inspection]
Data / ora di completamento	[da compilare]
Tipi di valutazione	[da compilare — es. cognitive walkthrough, action analysis, heuristic analysis: vedi Fase D]

DA COMPLETARE — Questa sezione va compilata dopo aver condotto le valutazioni di Fase D (inspection) sulla Version 0, e aver introdotto le modifiche conseguenti al design. Duplicare la tabella per ogni ulteriore iterazione (Version 2, Version 3...) se il team esegue più di un ciclo di revisione.

Final version (una sola, output principale della Fase C)

Nome cartella	main folder
Data / ora di completamento	[da compilare]
Tipi di valutazione	[da compilare — riassumere tutte le valutazioni svolte fino a questa versione]

DA COMPLETARE — La 'Final version' è per definizione l'ultima versione del design prima della valutazione conclusiva di Fase D (User Testing sul prototipo).

Finché Fase D non è stata condotta, Version 0 coincide di fatto con la versione più recente disponibile: aggiornare questa sezione quando il design verrà rivisto in base alle valutazioni.

Elenco delle criticità gestite nel redesign, in ordine di importanza

Ogni criticità è collegata ai requisiti delle Conclusion card di Fase A e Fase B, e alle sezioni di wireframe/blueprint che la indirizzano.

1. Autenticazione obbligatoria complessa fin dal primo passo

- Riferimento: [ID-01] Fase A, [P-01] Fase B, raccomandazione [R-01]
- Gestita in: Wireframe schermata 3 (Conferma identità leggera); Blueprint, passo 3; Before/After, confronto #2

2. Frammentazione tra domini/sottosistemi scollegati

- Riferimento: [ID-02] Fase A, raccomandazione [R-02]
- Gestita in: Information Architecture card (unificazione etichette e navigazione); Before/After, confronto #1

3. Assenza di un percorso guidato per il nuovo utente

- Riferimento: [ID-05] Fase A, [P-03] Fase B, raccomandazione [R-04]
- Gestita in: Wireframe schermate 1-2 (Home e scelta prestazione); Blueprint, passi 1-2

4. Interfaccia poco gerarchizzata, priva di elementi visivi

- Riferimento: [ID-03] Fase A, [P-02] Fase B, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: tutti i wireframe (uso sistematico di colore, forma e gerarchia visiva per le azioni primarie)

5. Terminologia tecnico-burocratica non spiegata

- Riferimento: [ID-04] Fase A, raccomandazione [R-03]
- Gestita in: Information Architecture card (sistema di etichettatura in linguaggio naturale); Wireframe schermata 5 (riepilogo senza gergo)

6. Ruolo del caregiver assente come concetto esplicito

- Riferimento: [P-04]/[P-05] Fase B, [C-02] Cast card
- Gestita in: Information Architecture card (nuova sezione 'Chi assisto'); Wireframe schermata 7; Before/After, confronto #3

7. Problemi di accessibilità per tecnologie assistive

- Riferimento: [ID-06] Fase A, raccomandazione [R-05]

DA COMPLETARE — Non ancora affrontata nei wireframe attuali (che sono lo-fi e non specificano markup/ARIA). Da riprendere esplicitamente in una eventuale versione ad alta fedeltà o nelle specifiche tecniche di implementazione, e da verificare concretamente in Fase D.

8. Cronologia appuntamenti/documenti non ordinabile o ricercabile

- Riferimento: [ID-07] Fase A
- Gestita parzialmente in: Wireframe schermata 6 (lista appuntamenti unificata, ordine cronologico con il prossimo appuntamento in evidenza)

Phase D — Evaluation

FASE D — Documento 01

Team card

Vedi Fase A, Documento 01 — Team Affordance (Matteo Boscherini, Alessandro Campedelli, Francesco Maria Fuligni).

FASE D — Documento 02a

Inspection card — Cognitive Walkthrough

Nome della versione valutata

Version 0 — v0_wireframe_iniziale (Fase C, Documenti 03-05: Blueprint, Wireframes, Before/After)

Dati di contesto dell'ispezione

- Data e ora: [da compilare con la data reale della sessione]
- Membri del team coinvolti e ruoli: un membro nel ruolo di Narratore (guida il walkthrough seguendo il compito), un membro nel ruolo di Ascoltatore/verbalizzatore (annota risposte e criticità), un membro nel ruolo di 'persona' (risponde alle domande impersonando Pina in base al suo profilo di Fase B)

Metodo di ispezione

- Cognitive Walkthrough

Compito valutato

Task equivalente a quello di Fase B (Persona card protagonista): Pina prenota la visita diabetologica di controllo semestrale, usando le schermate Wireframe 1→5 (Home, scelta prestazione, autenticazione leggera, data/ora, riepilogo/conferma).

Per ciascun passo, il walkthrough risponde alle 4 domande standard: (1) L'utente cercherà di ottenere l'effetto giusto? (2) L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile? (3) L'utente assocerà l'azione corretta all'effetto desiderato? (4) Se l'azione corretta viene eseguita, l'utente vedrà che sta facendo progressi?

Passo 1 — Dalla Home, toccare 'Prenota una visita' (Wireframe schermata 1)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	La visita di controllo è l'obiettivo esplicito di Pina; l'azione 'Prenota una visita' è coerente con questo obiettivo fin dal titolo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Il pulsante è il più grande e colorato della schermata, unico elemento con quel colore: alta salienza visiva anche per chi ha lieve difficoltà visiva (persona Pina, Fitness=2).
(3) Associazione corretta?	Sì	L'etichetta 'Prenota una visita' è in linguaggio naturale e coincide quasi letteralmente con l'obiettivo di Pina, riducendo il carico interpretativo (Domain=2, Technical=1).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta immediatamente alla schermata 2, con transizione visibile e nuovo titolo in alto.

Esito del passo

Successo previsto. Nessuna criticità rilevata su questo passo.

Passo 2 — Selezionare 'Diabetologia (di nuovo...)' (Wireframe schermata 2)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	L'opzione evidenziata corrisponde esattamente alla prestazione ricorrente di Pina.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	L'opzione è la prima della lista ed è evidenziata con colore e bordo distinti dalle altre tre.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Il testo aggiuntivo '(di nuovo, come l'ultima volta)' è utile, ma per un utente con bassa competenza tecnica (Technical=1) il concetto di 'ripetere' un'azione digitale potrebbe non essere immediatamente familiare quanto lo è nel mondo fisico (es. richiedere la stessa cosa allo sportello).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Il tocco porta alla schermata 3 con un nuovo titolo chiaro ('Conferma la tua identità').

Esito del passo

Successo previsto, con un'incertezza minore sul punto (3).

Grado assegnato

Buono (non Eccellente, per l'incertezza sul punto 3).

Raccomandazione di design

[W-01] Sostituire o affiancare l'icona 'R' con un'icona più universalmente riconoscibile (es. una freccia circolare) e valutare, in una versione ad alta fedeltà, un micro-test linguistico con utenti reali sul termine più efficace ('ripeti', 'prenota di nuovo', 'come l'ultima volta').

Passo 3 — Inserire il codice SMS e confermare (Wireframe schermata 3)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il testo spiega esplicitamente perché è richiesto il codice, riducendo l'ambiguità sull'obiettivo del passo.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo campo di inserimento, isolato visivamente, e un solo pulsante di conferma sotto di esso.
(3) Associazione corretta?	Parziale	Pina non ha mai usato l'autenticazione a due fattori: il concetto di 'codice temporaneo via SMS' è nuovo per lei, anche se più semplice di SPID. Il rischio è che non capisca da dove prendere il codice (deve uscire dall'app e controllare gli SMS).
(4) Percezione del progresso?	Sì	Dopo la conferma si passa alla schermata 4 (calendario), con contenuto chiaramente diverso.

Grado assegnato

Scarso, per il punto (3): è il passo più a rischio dell'intero flusso per il profilo di Pina.

Raccomandazione di design

[W-02] Aggiungere un'istruzione esplicita e illustrata ('Controlla i messaggi SMS del tuo telefono, poi torna qui') e valutare, in una versione successiva, un meccanismo di autofill del codice quando tecnicamente disponibile sul dispositivo, per eliminare il passaggio manuale tra app di messaggistica e app di prenotazione.

Passo 4 — Scegliere data e ora (Wireframe schermata 4)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Scegliere quando andare alla visita è un obiettivo intermedio ovvio per l'utente.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Gli slot disponibili sono evidenziati a colore rispetto a quelli non disponibili; lo slot 'consigliato' ha ulteriore enfasi.
(3) Associazione corretta?	Sì	Toccare una data/ora per sceglierla è un'azione fisica coerente con l'esperienza pregressa di Pina (calendari cartacei, sportelli).
(4) Percezione del progresso?	Sì	La selezione aggiorna visivamente lo slot scelto prima di passare al riepilogo.

Grado assegnato

Eccellente.

Passo 5 — Confermare la prenotazione (Wireframe schermata 5)

Domanda	Risposta	Motivazione
(1) Effetto giusto?	Sì	Il riepilogo motiva chiaramente perché si sta per confermare.
(2) Azione disponibile notata?	Sì	Un solo pulsante primario ben distinto da 'Torna indietro'.
(3) Associazione corretta?	Sì	'Conferma prenotazione' è inequivocabile rispetto all'obiettivo.
(4) Percezione del progresso?	Parziale	Il wireframe non mostra esplicitamente una schermata di 'successo' dopo la conferma (fuori scope del set attuale di schermate): l'utente potrebbe restare incerto se l'azione sia realmente completata.

Grado assegnato

Buono.

Raccomandazione di design

[W-03] Aggiungere alla versione successiva una schermata di conferma esplicita post-azione ('Prenotazione confermata ✓', con riepilogo e opzione per aggiungere al calendario del telefono), oggi non presente nel set di wireframe.

Esito complessivo del Cognitive Walkthrough

Il flusso è nel complesso ben allineato al profilo di Pina, con due punti di attenzione: il passo 3 (autenticazione leggera via SMS) resta il più rischioso, poiché introduce comunque un concetto nuovo per l'utente; e l'assenza di una schermata di conferma esplicita a fine flusso (punto 4 del passo 5) rischia di lasciare l'utente in una condizione di incertezza subito dopo l'azione più importante del task.

Nome della versione ridisegnata (se esistente come esito dell'ispezione)

DA COMPLETARE — Da produrre come `v1_dopo_inspection` se il team decide di implementare le raccomandazioni [W-01], [W-02], [W-03] prima di procedere con Formative/Summative test. In tal caso, aggiornare anche la Design summary card di Fase C (Documento 06).

FASE D — Documento 02b

Inspection card — Heuristic Analysis

Nome della versione valutata

Version 0 — `v0_wireframe_iniziale` (Fase C, Documenti 03-05)

Dati di contesto dell'ispezione

- Data e ora: [da compilare]
- Membri del team coinvolti: valutazione condotta indipendentemente da ciascun membro del team e poi discussa in gruppo, secondo prassi standard dell'analisi euristica

Metodo di ispezione

- Heuristic Analysis — 10 euristiche di Nielsen, applicate all'intero set di Wireframe (schermate 1-7) e al Blueprint

Euristica	Grado	Giustificazione
1. Visibilità dello stato del sistema	Buono	Il 'Prossimo appuntamento' in home e il calendario con slot evidenziati mostrano sempre lo stato corrente; manca però una conferma esplicita di successo a fine flusso (vedi [W-03]).
2. Corrispondenza sistema-mondo reale	Eccellente	Linguaggio naturale ('Prenota una visita', 'I miei appuntamenti') al posto di nomi di sistema; metafora del calendario cartaceo per la selezione data/ora.
3. Controllo e libertà dell'utente	Buono	'Torna indietro' presente nel riepilogo; manca però un tasto di annullamento esplicito durante il passo di autenticazione leggera (schermata 3).
4. Coerenza e standard	Eccellente	Barra di navigazione identica su tutte le schermate; stile dei pulsanti (colore verde = azione primaria) coerente in tutto il set.
5. Prevenzione degli errori	Scarso	Nella schermata 4 (data/ora) non è ancora chiaro cosa succeda se l'utente prova a toccare uno slot non disponibile (grigio): il wireframe non specifica un feedback di errore/impedimento.
6. Riconoscimento piuttosto che ricordo	Eccellente	La prestazione ricorrente è mostrata direttamente in home; l'utente non deve ricordare nulla per avviare il task più frequente.
7. Flessibilità ed efficienza d'uso	Buono	La scorciatoia 'ripeti' per Pina è efficiente; per un utente esperto come Elena (persona caregiver) manca però una vista compatta/tabellare pensata per la velocità, oggi la dashboard 'Chi assisto' è pensata principalmente in stile mobile semplice.
8. Design estetico e minimalista	Eccellente	Ogni schermata contiene solo gli elementi strettamente necessari al passo corrente, coerente con il requisito [P-02] di Fase B (bassa competenza tecnica di Pina).

9. Aiutare a riconoscere e recuperare dagli errori	Scarso	Il set di wireframe attuale non include una schermata di errore (es. codice SMS errato, slot non più disponibile al momento della conferma): comportamento non specificato.
10. Guida e documentazione	Buono	La voce 'Serve aiuto?' in barra di navigazione è sempre presente; il suo contenuto interno non è stato ancora progettato in questa iterazione (fuori scope dei 7 wireframe realizzati).

Raccomandazioni di design

- [H-01] (euristica 5, 9) Aggiungere alla prossima iterazione due schermate di errore esplicite: codice SMS errato/scaduto, e slot non più disponibile al momento della conferma — entrambe con messaggio in linguaggio semplice e azione di recupero chiara
- [H-02] (euristica 3) Aggiungere un'azione di annullamento esplicita anche nel passo di autenticazione (schermata 3), non solo nel riepilogo finale
- [H-03] (euristica 7) Valutare, in una versione successiva o in una variante 'desktop' per il caregiver, una vista più densa e tabellare della dashboard 'Chi assisto', più adatta a un utente esperto come Elena che gestisce più familiari o più appuntamenti contemporaneamente

Nome della versione ridisegnata (se esistente come esito dell'ispezione)

DA COMPLETARE — Come per il Cognitive Walkthrough: da produrre come **v1_dopo_inspection** se le raccomandazioni [H-01]/[H-02]/[H-03] vengono implementate prima delle fasi di test con utenti reali.

FASE D — Documento 03

Formative test card

Una card per ogni versione testata. Questa card riguarda la Version 0 (o la v1_dopo_inspection, se prodotta). Il protocollo sottostante è pronto per l'esecuzione; le sezioni che richiedono soggetti reali sono segnalate esplicitamente.

Nome della versione

[da compilare — Version 0 oppure v1_dopo_inspection, secondo quanto deciso dal team dopo l'Inspection card]

Setup della sessione di test

Test in presenza, sugli stessi dispositivi/soggetti già coinvolti nello User Testing preliminare di Fase A quando possibile (per continuità e confrontabilità), altrimenti su nuovi soggetti reclutati con gli stessi criteri. Il wireframe può essere mostrato tramite prototipo cliccabile (consigliato, es. esportando le slide come immagini navigabili) o, in alternativa, tramite simulazione 'Mago di Oz' guidata da un membro del team che mostra la schermata successiva a ogni tocco del soggetto.

Metodo di test

- Discount usability testing (3-5 persone)

Elenco dei task da testare

- T1 — Da Home, prenotare la visita diabetologica di controllo ricorrente (schermate 1→5)
- T2 — Individuare come disdire un appuntamento già fissato (schermata 6)
- T3 — (solo per soggetti nel ruolo caregiver) Individuare lo stato dell'ultimo appuntamento del familiare assistito (schermata 7)

Metodologia di test

- Thinking aloud per T1 e T3
- Bottom line data per T2

Metriche di test

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS)

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

DA COMPLETARE — Da completare con soggetti reali, con le stesse caratteristiche indicate per lo User Testing preliminare di Fase A (segmento A: 65-85 anni, bassa/media competenza digitale; segmento B: caregiver familiare 45-60 anni). Nome fittizio, età, genere, competenza tecnica, somiglianza al segmento, relazione col team.

Modalità di reclutamento dei soggetti

DA COMPLETARE — Da completare, dichiarando onestamente come sono stati trovati i soggetti.

Motivazione della scelta dei soggetti

DA COMPLETARE — Da completare con onestà.

Le sezioni 'Test #1: Subject...' (una per soggetto reale, con dati qualitativi/quantitativi, punteggio SUS dal modulo Google del corso, riflessioni utili per il design) e la sezione conclusiva 'SUS average and variance / Outcomes and reflections (~300 parole) / Urgency curve / Nome della versione ridisegnata' vanno aggiunte non appena i test saranno stati condotti. Il protocollo sopra è pronto per essere eseguito.

FASE D — Documento 04

Summative test card

Una sola card, sulla versione finale del design ("o la va o la spacca"). Da eseguire solo dopo aver chiuso il ciclo di test formativi e le relative modifiche.

Nome della versione finale

DA COMPLETARE — Da compilare con il nome della versione finale (main folder di Fase C, eventualmente aggiornata in base agli esiti dei test formativi).

Setup della sessione di test

Stesso impianto metodologico del test formativo, preferibilmente con soggetti nuovi rispetto a quelli già esposti al design nei cicli precedenti, per evitare effetti di apprendimento che falsino il risultato conclusivo.

Metodo di test

- Discount usability testing (2-5 persone) oppure Full usability testing (20-50 persone), a seconda del tempo disponibile al team; indicare la scelta effettiva

Elenco dei task da testare

- Stesso set di task del test formativo (T1, T2, T3), per garantire la confrontabilità dei risultati prima/dopo

Metodologia di test

- Thinking aloud per T1/T3, Bottom line data per T2, coerentemente con il test formativo

Metriche di test

- Success, Efficiency, Efficacy, Errors, Learnability, Satisfaction (SUS) — obbligatoria la Satisfaction come richiesto dalla card

Reclutamento dei soggetti (persone reali)

DA COMPLETARE — Da completare con soggetti reali al termine del ciclo di test formativi, seguendo gli stessi criteri di rappresentatività dei segmenti A e B.

Motivazione della scelta dei soggetti

DA COMPLETARE — Da completare con onestà.

Le sezioni 'Test #1: Subject...' e la sezione conclusiva finale (SUS average and variance, altre metriche quantitative, Conclusions) vanno aggiunte al termine dell'esecuzione dei test. Questa è la valutazione conclusiva dell'intero progetto HPHP: va condotta per ultima, a valle di tutte le altre fasi.

Protocollo di test rapido

Sessione unica — 15/20 minuti a persona

Copre insieme: User Testing preliminare (Fase A) + Formative test (Fase D)

Team Affordance — HPHP

Stampate questo documento e portatelo con voi durante il test.

Prima di iniziare

Cosa vi serve

- Questo documento stampato (o su un secondo dispositivo)
- Un dispositivo con l'app ER Salute installata o il sito cupweb.it aperto nel browser (idealmente il telefono/PC della persona stessa)
- Le 7 schermate del wireframe v1 pronte da mostrare in sequenza (es. `phase-c-wireframe-s-v1.pptx` aperto in modalità presentazione, oppure stampate)
- Un modo per prendere appunti (questo documento stesso, o un foglio a parte)
- Il link al modulo Google SUS fornito dal corso, aperto e pronto

Chi coinvolgere

Bastano 2-3 persone. L'ideale è chi assomiglia il più possibile ai due segmenti di Fase A: una persona 65-85 anni con bassa/media familiarità col digitale (segmento A), e/o una persona 45-60 anni che gestisce le pratiche di un familiare anziano (segmento B). Va benissimo se sono conoscenti o parenti: basta dichiararlo onestamente nella card, come richiesto dal corso stesso.

Ruoli nel team (se siete in due)

- Conduttore: legge le istruzioni, osserva, non aiuta se non richiesto esplicitamente
- Verbalizzatore: prende appunti su questo documento durante il test

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie per il tuo aiuto. Ti mostrerò due cose legate a un'app per prenotare visite mediche, e ti chiederò di provare a fare alcune azioni pensando ad alta voce, cioè dicendomi cosa stai guardando e cosa stai per fare. Non c'è nulla di giusto o sbagliato: sto testando l'app, non te. Se ti blocchi va benissimo, è un'informazione utile. Possiamo interrompere quando vuoi."*

Parte 1 — Il sito/app reale (5 minuti)

Tempo stimato: circa 5 minuti

Copre: User Testing preliminare card, Fase A (Documento 06a).

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Apri il sito cupweb.it (o l'app ER Salute) come se dovessi prenotare una visita di controllo per te stesso/a. Dimmi ad alta voce cosa stai guardando e cosa faresti."*

Task A — Trovare come prenotare (senza completare la prenotazione)

Lascia che la persona esplori per un massimo di 2 minuti. Non intervenire, annota dove clicca, dove esita, cosa dice.

Task B — Trovare come si disdirebbe un appuntamento

Chiedi: "Se avessi già una visita prenotata e non potessi più andarci, dove andresti a guardare per disdirla?" Lascia indicare senza completare l'azione.

Annotazioni — Task A e B

Osservazione	Note
Riesce a capire dove cliccare per prenotare?	
Momenti di esitazione o confusione (dove, cosa ha detto)	
Riesce a individuare la disdetta?	
Commenti spontanei rilevanti (citazioni dirette)	

Parte 2 — Il nuovo design, wireframe v1 (7 minuti)

Tempo stimato: circa 7 minuti

Copre: Formative test card, Fase D (Documento 03). Mostrate le schermate del wireframe v1 una alla volta, come se fosse l'app vera.

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ora ti mostro una proposta di come potrebbe diventare questa app. Immagina che sia già installata sul tuo telefono. Ti chiedo di nuovo di pensare ad alta voce."*

Task C — Prenotare la visita ricorrente (schermate 1→5b)

Mostra la schermata 1 (Home). Chiedi: "Come prenoteresti la tua prossima visita di controllo?" Segui il suo percorso mostrando le schermate corrispondenti a ogni tocco/scelta indicata.

Task D — Disdire un appuntamento (schermata 6)

Mostra la schermata 6. Chiedi: "E se dovessi disdire, cosa faresti qui?" — questo task va lasciato in bottom line data: osserva senza commentare durante l'esecuzione.

Annotazioni — Task C e D

Osservazione	Note
Trova subito il pulsante 'Prenota una visita'?	
Capisce il passo di autenticazione via SMS (schermata 3)?	
Reazione alla schermata di conferma finale (5b)	

Riesce a trovare 'Disdici' senza aiuto?
 Confronto spontaneo con la Parte 1 (dice se gli sembra più semplice/difficile)

Parte 3 — Questionario e chiusura (3-5 minuti)

Tempo stimato: circa 3–5 minuti

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Ultima cosa: ti faccio 10 semplici domande a cui rispondere con un punteggio da 1 a 5, riferendoti alla nuova versione che ti ho appena mostrato. Non c'è una risposta giusta."*

Somministrare il modulo Google SUS del corso (schermate v1). Non modificare l'ordine né le parole delle prime 10 domande.

Promemoria delle 10 domande standard SUS (in italiano), da usare solo come riferimento — la somministrazione ufficiale avviene tramite il modulo Google del corso:

#	Domanda
1	Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente
2	Ho trovato il sistema inutilmente complesso
3	Ho trovato il sistema facile da usare
4	Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per usare questo sistema
5	Ho trovato che le varie funzioni di questo sistema fossero ben integrate
6	Ho trovato troppa incoerenza in questo sistema
7	Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente
8	Ho trovato il sistema molto scomodo da usare
9	Mi sono sentito/a molto sicuro/a nell'usare questo sistema
10	Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di riuscire ad usare questo sistema

Domande di chiusura (facoltative, in linguaggio libero)

- C'è qualcosa che ti ha confuso più di altro?
- Cosa cambieresti, se potessi cambiare una sola cosa?
- Ti fideresti a usare questa versione da solo/a, senza chiedere aiuto a nessuno?

DA LEGGERE AD ALTA VOCE: *"Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, sei stato/a davvero utile."*

Scheda soggetto — da compilare dopo ogni sessione

Compilate una copia di questa pagina per ciascuna persona testata. I dati confluiranno nelle card ufficiali (Fase A, Documento 06a; Fase D, Documento 03).

Campo	Valore
-------	--------

Nome (fittizio, per
anonimizzare)
Età
Genere
Background tecnico (1 riga)
Somiglianza al segmento (A:
paziente / B: caregiver)
Relazione con il team
Data e ora del test
Assistente del test (membro del
team)
Durata effettiva
Task A completato?
(sì/no/parziale)
Task B completato?
(sì/no/parziale)
Task C completato?
(sì/no/parziale)
Task D completato?
(sì/no/parziale)
Punteggio SUS totale (dal
modulo Google)
Citazione/osservazione più utile
per il design
